

Revisión crítica de un caso de infiltraciones articulares

Valoración experta de diagnósticos, pruebas y tratamiento · Segunda opinión documental

PACIENTE · Mujer, 60 a.
SEGUIMIENTO · 2015 – 2026
DOCUMENTO · Anonimizado
EMISIÓN · 10-jun-2026

- Caso anonimizado conforme a protección de datos: se han
- suprimido nombre, NHC, fecha de nacimiento y centro. Los facultativos se identifican como

Facultativo A y Facultativo B .

01 Resumen del caso

Mujer de 60 años con artrosis **poliarticular, bilateral y simétrica** en cadera, tobillo y retropié, tratada de forma esencialmente exclusiva con infiltraciones intraarticulares de ácido hialurónico (viscosuplementación), repetidas con periodicidad casi anual a lo largo de más de una década.

La documentación disponible consiste únicamente en **informes de procedimiento intervencionista**. No se aporta historia clínica funcional, exploración física estructurada, escalas de dolor/función, ni informes de imagen con graduación. La revisión que sigue se basa, por tanto, en lo que estos informes permiten inferir, y señala de forma explícita lo que falta para una toma de decisiones sólida.

FECHA	DIAGNÓSTICO REGISTRADO	LOCALIZACIÓN	FÁRMACO / DOSIS	FACULT.
15·05·2015	Coxartrosis bilateral	Cadera	AH (Ostenil Plus)	A
12·03·2021	«AFA» bilateral (descrita coxofemoral)	Cadera	AH (Hialone) ×2	A
01·03·2023	«AFA» bilateral	Cadera	AH (Hialone) ×2	B
07·03·2024	«AFA» bilateral	Cadera	AH (Hialone) ×2	A
05·03·2025	«AFA» bilateral	Cadera	AH (Hialone) ×2	A
02·04·2025	Artrosis tibioastragalina bilateral	Tobillo	AH (Hialone) ×2	A
09·05·2025	Artrosis astrágalo-escafoidea bilateral	Retropié	AH (Hyalubrix) ×1	B
05·03·2026	Coxartrosis bilateral	Cadera	AH (Hyalubrix) ×2	A
08·05·2026	Artrosis tibioperoneoastragalina + astrágalo-escafoidea bilateral	Tobillo Retropié	AH (Hyalubrix) ×3	B

AFA = ABREVIATURA NO ESTANDARIZADA EMPLEADA EN LOS INFORMES; POR LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA («ARTICULACIÓN COXOFEMORAL»), CORRESPONDE A ARTROSIS DE CADERA.

02 Lectura global del experto

Lo primero que llama la atención no es ninguna infiltración aislada —técnicamente correctas, ecoguiadas, con consentimiento y sin complicaciones— sino el **patrón de conjunto**. Una mujer que desde finales de la quinta década desarrolla artrosis **en ambas caderas, ambos tobillos y ambos retropiés** de forma simétrica no encaja bien con la artrosis primaria mecánica habitual, y en cambio sí encaja con un proceso de base que afecta al cartílago de manera generalizada.

Mi principal objeción al manejo no es que se infiltre, sino que durante **once años el caso se haya tratado como una sucesión de articulaciones que se van «gastando»**, abordadas una a una con viscosuplementación, sin que conste que se haya formulado la pregunta clave: *¿por qué esta paciente tiene artrosis en tantas articulaciones, y tan jóvenes?*

03 El hallazgo central: una artrosis poliarticular que pide estudio etiológico

La artrosis de **tobillo** es, en sí misma, un dato relevante: a diferencia de cadera y rodilla, la artrosis tibioastragalina **primaria es infrecuente** ($\approx 5\text{--}10\%$ de los casos); la inmensa mayoría es **secundaria** a traumatismo, inestabilidad o malalineación. Que aparezca **bilateral y simétrica**, además junto a artrosis de retropié y de ambas caderas, refuerza la sospecha de una causa subyacente.

■ BANDERA ROJA · DESCARTAR ARTROPATÍA SECUNDARIA / METABÓLICA

El patrón **poliarticular + bilateral + simétrico + de inicio relativamente precoz** obliga a descartar causas sistémicas antes de seguir asumiendo «artrosis degenerativa primaria» como diagnóstico de trabajo. Entre las entidades a considerar:

- **Hemocromatosis** — artropatía con predilección por 2.^a-3.^a MCF, muñeca, tobillo y cadera; osteofitos «en gancho». Encaja especialmente con el componente de tobillo.
- **Condrocálculos / depósito de pirofosfato cálcico (EDPC)** — artrosis de distribución atípica (incluida la femoropatelar, muñeca, tobillo) y brotes pseudogotosos.
- **Artropatías inflamatorias** (AR, espondiloartropatías) o por depósito (gota tofácea de larga evolución).
- **Otras:** ocronosis/alcaptonuria, acromegalia, displasia/hiperlaxitud, osteonecrosis bilateral de cadera (corticoides, alcohol).

Estudio mínimo recomendado antes de continuar infiltrando

- **Analítica:** ferritina y *índice de saturación de transferrina* (cribado de hemocromatosis), glucemia/HbA1c, calcio, fósforo, magnesio, PTH, ácido úrico, función renal y hepática.
- **Inflamación/autoinmunidad:** VSG, PCR, factor reumatoide, anti-CCP, ANA.
- **Imagen:** radiografía de *manos/muñecas y rodillas* buscando condrocálculos y osteofitos en gancho; radiografías en carga de tobillo con **medición de la alineación** (varo/valgo, ángulo TAS), clave para decidir tratamiento.
- Si ferritina/saturación elevadas → **genotipado HFE** y derivación a Digestivo/Hematología.

DETECTAR UNA CAUSA TRATABLE (P. EJ. SOBRECARGA FÉRRICA) CAMBIARÍA POR COMPLETO EL PRONÓSTICO Y EL PLAN, MÁS ALLÁ DE ALIVIAR CADA ARTICULACIÓN POR SEPARADO.

04 Valoración de los diagnósticos

Los diagnósticos articulares son, en su mayoría, **plausibles y coherentes** con la clínica que motiva una infiltración ecoguiada. No obstante, como diagnósticos para fundamentar un tratamiento mantenido durante años, presentan debilidades:

- **Son diagnósticos de localización, no de causa.** «Coxartrosis bilateral» o «artrosis tibioastragalina bilateral» describen *dónde* duele, pero no *por qué*; falta el diagnóstico etiológico y la graduación (Kellgren-Lawrence) que justifique la intensidad del tratamiento.
- **No constan los criterios diagnósticos.** No se aporta la imagen, ni hallazgos ecográficos (derrame, sinovitis, osteofitos), ni exploración. El diagnóstico parece sostenerse en el propio acto de infiltrar.
- **Terminología inconsistente.** La misma articulación (cadera) se etiqueta como «coxartrosis», «AFA bilateral» y se describe como «coxofemoral»; «AFA» es una abreviatura no estandarizada. Esto dificulta el seguimiento y la trazabilidad.

■ INCONSISTENCIAS DOCUMENTALES DETECTADAS

En las infiltraciones de **cadera** de 2024 y 2025 figura como complicación *«hipertonía de trapecios, elevadores de la escápula y angulares bilateral»* — musculatura cervicoescapular sin relación con una infiltración coxofemoral. Tiene aspecto de **texto copiado** de otro registro. Aunque menor, este tipo de error resta fiabilidad al informe y tiene relevancia medicolegal.

5.1 · Sobre la viscosuplementación y su evidencia

La técnica está bien ejecutada (ecoguiada, asepsia, consentimiento, sin complicaciones). El problema es de **indicación y de evidencia**, que difiere mucho según la articulación:

- **Cadera:** es el punto más débil. Las guías **ACR 2019 recomiendan *en contra*** del ácido hialurónico intraarticular en coxartrosis, y la OARSI no lo recomienda; la evidencia de eficacia frente a placebo es escasa e inconsistente. Mantener infiltraciones de cadera anuales durante ~11 años se aparta de la recomendación vigente.
- **Tobillo y retropié:** la evidencia es **limitada y de baja calidad** (estudios pequeños, sin recomendación firme en guías). Puede ser una opción razonable en casos seleccionados que han agotado medidas de base, pero no como tratamiento de primera línea ni indefinido.

■ EL PUNTO QUE MÁS ME PREOCUPA · AUSENCIA DE MEDICIÓN DE RESULTADOS

No consta **ninguna métrica de eficacia**: ni EVA de dolor, ni escalas funcionales (WOMAC, Lequesne, FAOS), ni balance articular, ni registro de respuesta a infiltraciones previas. Se repite el tratamiento cada año («PR 1 año») de forma casi **ritualizada**, sin un umbral explícito de éxito o de retirada. **Si no se mide, no puede saberse si funciona**, y se corre el riesgo de cronificar un procedimiento que quizá no aporta beneficio sostenido.

5.2 · La gran ausencia: el tratamiento de base de la artrosis

Todas las guías (OARSI 2019, ACR 2019, EULAR, NICE) coinciden en que el **núcleo del tratamiento de la artrosis es no farmacológico**: ejercicio terapéutico, educación y autocuidado, y control del peso. Las infiltraciones son, en el mejor de los casos, un *complemento*. En esta historia no consta ninguno de esos pilares:

- Sin programa estructurado de **ejercicio terapéutico** (fuerza, rango, propiocepción) ni fisioterapia documentada.
- Sin **educación, autocuidado ni control de peso** registrados.
- Sin **ortesis ni adaptaciones del calzado**, pese a que el tobillo y el retropié son donde más rinden (plantillas, tobillera, suela de balancín, cuñas correctoras de alineación).
- Sin escalonamiento farmacológico básico (AINE tópico, analgesia oral pautada y revisada).

Dicho de otro modo: durante una década se ha ofrecido de forma reiterada la intervención *menos respaldada por la evidencia* (sobre todo en cadera), mientras que las intervenciones de **primera línea** no aparecen documentadas.

06 Alternativas terapéuticas

Reordenadas según la pirámide de evidencia: primero la base común, después medidas por articulación y, al final, lo intervencionista y quirúrgico.

Base común (1.ª línea, todas las articulaciones)

NÚCLEO DEL TRATAMIENTO

- Programa de **ejercicio terapéutico** supervisado: fuerza, movilidad y propiocepción.
- **Educación y autocuidado**; control de peso si procede.
- **Terapia acuática**, útil con varias articulaciones de carga afectadas.
- AINE **tópico** de primera elección; oral pautado/revisado con gastroprotección; duloxetina en dolor crónico.

Tobillo y retropié

DONDE MÁS RINDE EL ABORDAJE CONSERVADOR

- **Ortesis**: plantillas a medida, tobillera estabilizadora, AFO en casos avanzados.
- **Calzado**: suela de balancín (*rocker*), cuñas/realces para corregir varo-valgo.
- Valorar **alineación**: si hay malalineación corregible → **osteotomía supramaleolar**.
- Fases finales: **artrodesis** o **artroplastia total de tobillo** según paciente.

Cadera

RECONSIDERAR LA VISCOSUPLEMENTACIÓN

- Fisioterapia específica de cadera; **bastón contralateral** para descargar.
- **Infiltración de corticoide** ecoguiada para brotes (efecto corto), en lugar de AH crónico.
- Si artrosis terminal e incapacitante → derivación para **artroplastia total de cadera**, de eficacia muy contrastada.

Intervencionista / emergente

CON CAUTELA Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

- **PRP**: evidencia creciente pero aún limitada en cadera y tobillo; no como estándar.
- Corticoide intraarticular para **reagudizaciones** puntuales.
- Si se mantiene el AH, hacerlo **con objetivos y métricas** y retirarlo si no hay beneficio medible.

07 Recomendaciones priorizadas

- 1 Reevaluación clínica integral** INMEDIATO
Historia, exploración, balance articular y **escalas basales** (EVA, WOMAC/Lequesne para cadera, FAOS para tobillo) para tener un punto de partida medible.
- 2 Estudio etiológico de la artrosis poliarticular** PRIORITARIO
Analítica (ferritina/saturación de transferrina, calcio, PTH, ácido úrico, perfil inflamatorio) y radiografías de manos/rodillas/tobillo en carga con alineación. Derivar a Reumatología si procede.
- 3 Instaurar el tratamiento de base** PRIMERAS SEMANAS
Ejercicio terapéutico supervisado, educación, control de peso y AINE tópico; en tobillo/retropié, ortesis y adaptación del calzado.
- 4 Replantear la viscosuplementación** EN LA PRÓXIMA CITA
Suspender el AH de **cadera** salvo evidencia objetiva de beneficio (va en contra de las guías). Mantener el de tobillo solo dentro de un plan con objetivos y reevaluación.
- 5 Corregir la documentación** CONTINUO
Unificar terminología diagnóstica, registrar criterios e imagen, y eliminar el texto copiado de complicaciones erróneo.
- 6 Definir umbrales y derivación quirúrgica** SEGÚN EVOLUCIÓN
Criterios explícitos de éxito/fracaso y derivación a Traumatología (artroplastia de cadera, osteotomía/artrodesis/artroplastia de tobillo) cuando el conservador se agote.

Alcance y limitaciones. Esta es una **revisión documental y crítica** elaborada únicamente a partir de los informes de procedimiento aportados, sin acceso a la historia clínica completa, imagen, exploración física ni a la paciente. No sustituye a una valoración presencial ni constituye una indicación terapéutica directa; su finalidad es servir de **segunda opinión orientativa** para el equipo tratante. Las referencias a guías (ACR 2019, OARSI 2019, EULAR, NICE) reflejan el marco de práctica habitual; las decisiones finales deben individualizarse. Documento **anonimizado**: sin datos identificativos del paciente, los facultativos ni el centro.